밤에 종아리에 쥐가 날 때

갑자기 아픈 근육 경련을 푸는 법과 병원에 알려야 할 신호를 알아봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

정말 근육에 쥐가 난 걸까요

50세 이상 약 33%, 60세 이상 약 50%가 겪습니다. 근육이 실제로 뭉치는지 먼저 확인하세요.

실제 근육 경련(true cramp)이란

종아리 근육이 갑자기 단단하게 뭉치며 몹시 아픕니다. 보통 수 초~수 분, 드물게 10분 이어집니다. 풀린 뒤에도 48~72시간 누르면 아플 수 있습니다.

병력에서 묻는 세 가지

근육이 실제로 뭉치는지, 늘려 주면 풀리는지, 쉴 때인지 걸을 때인지 기억해 두세요.

헷갈리는 것	구별점
근구축(contracture)	겉보기엔 쥐 같지만 근전도가 조용함(**전기적 침묵**) · 스트레칭으로 안 풀림
근간대경련	0.2초 이내로 짧게 홱 움직임 · 통증 없음
근긴장이상	반대 방향 근육이 함께 수축해 자세가 비틀림
테타니	양쪽 대칭 · Chvostek·Trousseau 징후 양성
하지불안증후군	움직이고 싶은 충동만 · 실제로 뭉치지 않음(국내 유병률 5.4~7.5%)

실천 · 근육이 굳는지, 걷다가 아픈지 구분해 진료 때 말씀해 주세요.

출처 · 마지막 장

왜 밤에 종아리가 굳을까요

신경이 근육을 갑자기 수축시키는 일이 흔합니다.

말초 운동신경 과흥분

이 경련은 근육에 신호를 보내는 신경 끝에서 시작되는 것으로 보입니다.

근방추·골지건기관 불균형

근육이 짧아진 채 피로가 쌓이면 흥분은 늘고 억제는 줄어듭니다. 스트레칭이 바로 듣는 이유입니다.

TRP 채널 매개 가설

입안 자극이 신경의 과도한 반응을 줄일 수 있다는 설명이 있지만, 아직 연구 단계의 가설입니다.



실천 · 경련이 반복되는 시간과 부위를 적어 두세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 증상은 원인을 확인해야 합니다

걷거나 움직일 때만 아프거나 감각이 달라지면 알려 주세요.



이럴 땐 원인 검사부터

한쪽 다리에만 반복되거나, 팔·몸통에도 생기거나, 힘이 빠지고 근육이 마르면 진료받으세요. 걸을 때만 아프거나 새 약을 시작한 뒤 생겼다면 꼭 알려 주세요.

약이 원인일 때

이뇨제 · 베타작용제 · 스타틴 · 니페디핀 · 호르몬제 — 어느 쪽이 먼저인지가 핵심입니다.

바탕에 다른 병이 있다는 신호

간경변 · 만성콩팥병·투석 · 갑상선 · 당뇨 신경병증 · 임신 · 몸속 소금 성분 이상.

실천 · 붓기·한쪽 다리 통증·감각 이상이 함께 있으면 진료받으세요. 숨이 차거나 가슴이 아프면 바로 응급실로 가세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

복용 중인 약도 확인하세요

새로 시작한 약과 건강 상태를 함께 살펴봅니다.

확인하는 순서

최근 3개월에 새로 시작하거나 용량을 올린 약이 있나요? 경련보다 먼저였는지 확인하고, 조정은 처방 의사와 상의하세요.

약을 더하기 전에

경련약을 더 먹기 전에 현재 복용약이 원인인지 함께 살펴봅니다. 스스로 약을 끊지는 마세요.

약	어떻게 경련을 부르나	확인할 것
이뇨제	칼륨·마그네슘 저하	몸속 소금 성분 · 시작 시점과 증상 시점
흡입 β작용제	몸속 소금 성분을 흔듦	시작·증량 시점과 비교
위산억제제(PPI) 장기	마그네슘 저하	마그네슘 · 계속 필요한지
스타틴	근육에 직접	근육효소(CK) 확인 후 감량·변경 검토
니페디핀 · 랄록시펜· 에스트로겐 · 정맥 철분제	보고된 약	시작 시점과 비교 · 바꿀 수 있는지

실천 · 약 봉투를 가져오고 약은 스스로 끊지 마세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

검사는 증상에 맞춰 고릅니다

전형적인 경련은 먼저 이야기와 진찰로 평가합니다.

1 · 기본

다른 원인이 의심되면

단서가 있으면 나트륨·칼륨·칼슘(알부민 보정)·마그네슘, 혈당/당화혈색소, 콩팥·간·갑상선(TSH) 수치를 봅니다. 근육통이 있으면 근육효소(CK)도 봅니다.

2 · 상황별

의심될 때 추가

술·영양결핍 → 인(P) · 하지불안증후군 구별 → 페리틴 · 신경병증 의심 → 비타민 B12.

3 · 의뢰

큰 병원으로

힘 빠짐·근육 마름·실룩거림 → 신경검사. 걸을 때 통증·발 맥박 약함 → 발목-팔 혈압비(ABI). 다리로 뻗는 통증 → 허리 MRI.

다른 원인이 없다면

진찰과 필요한 검사에서 다른 원인이 보이지 않으면 흔한 야간 근육 경련으로 봅니다.

실천 · 검사 전에 증상이 생기는 상황을 자세히 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먼저 종아리를 늘려 주세요

쥐가 나면 발끝을 몸 쪽으로 천천히 당깁니다.

자기 전 종아리·허벅지 뒤 스트레칭

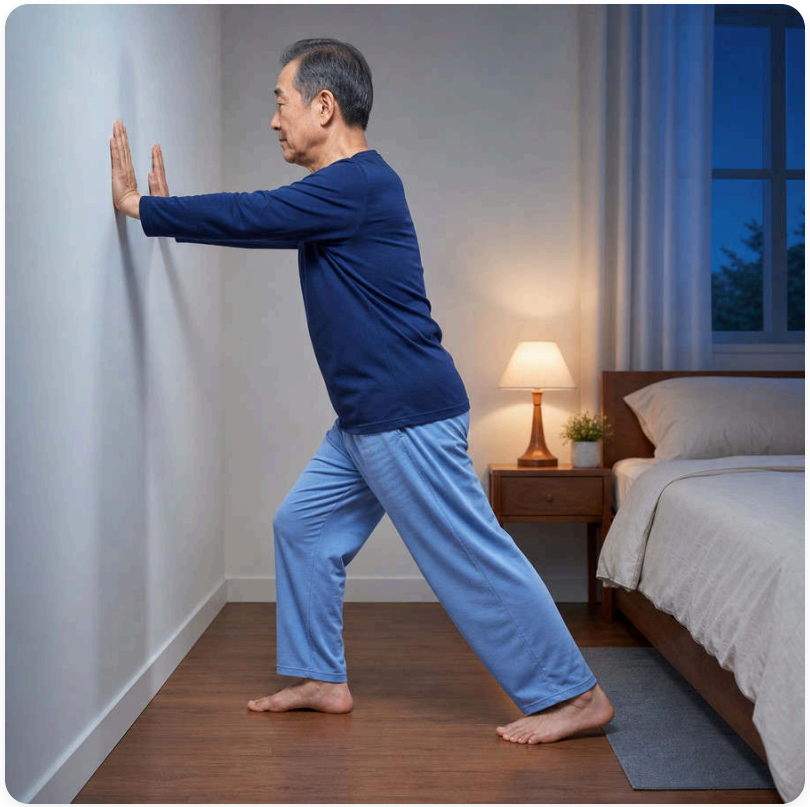
고령자 비교 연구에서는 자기 전 종아리 스트레칭이 경련 횟수와 강도를 줄였습니다.

실제로 하는 방법

벽을 짚고 뒷다리 무릎을 펴서 종아리를 10초씩 3회 늘려 주세요. 자기 전에 매일 해 보세요.

다시 평가하는 때

스트레칭을 6주 해 본 뒤 다시 평가합니다. 잠자리 자세, 수분, 카페인과 술도 함께 살펴보세요.



실천 · 쥐가 나면 무릎을 펴고 발끝을 몸 쪽으로 천천히 당기세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

잠자는 자세도 살펴보세요

발끝이 오래 아래로 향하지 않게 이불과 자세를 조절합니다.



무엇이 문제인가

이불 무게로 발끝이 **밤새 아래로** 향하면 종아리가 짧아진 채 피로가 쌓입니다.

바꿀 것

발치 쪽 이불을 느슨하게 해 발등이 눌리지 않게 합니다. 필요하면 베개로 발목을 **바로 세워** 받칩니다.

같이 바꿀 것

수분 · 카페인·술 줄이기 · 활동량 유지(너무 적어도, 갑자기 늘려도 경련이 옵니다).

실천 · 이불이 발끝을 누르는지 오늘 밤 확인해 보세요.

출처 · 마지막 장

마그네슘과 경련약, 무엇을 알까요

마그네슘의 효과는 확인되지 않았고 일부 약은 위험할 수 있습니다.

마그네슘 — 근거는 음성

다른 원인이 없는 야간 경련에는 마그네슘이 가짜약보다 낫다고 입증되지 않았습니다. 임신·검사로 확인된 부족·이뇨제 또는 위산 억제제 장기 복용은 따로 상의하세요.

퀴닌 — 쓰지 않습니다

퀴닌은 경련을 줄일 수 있지만 피를 멎게 하는 혈소판이 줄거나 심장 박동에 문제가 생길 수 있어 여러 나라에서 사용을 제한합니다.

약	근거	판단
딜티아젬	규모가 작은 무작위 시험의 긍정적 신호 PMID 11322688	권고하기엔 이릅니다
비타민 B 복합	소규모 무작위 시험 PMID 11301568	보조적으로만
타우린	간경변 환자 경련 무작위 대조시험 PMID 30136291	간경변일 때(다음 장)

실천 · 마그네슘이나 경련약을 임의로 시작하지 마세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

쥐가 난 순간 이렇게 해 보세요

잠결에도 할 수 있도록 진료실에서 한 번 연습해 보세요.

01

손으로 늘려 펴기

쥐가 나면 무릎을 펴고 발끝을 몸 쪽으로 당겨 종아리를 늘리세요. 풀린 뒤에는 마사지나 온찜질을 할 수 있습니다.

가장 먼저 할 일

02

피클 주스 반사 억제

실험에서는 피클 주스를 조금 마셨을 때 경련이 짧아졌지만, 실제 밤 경련 치료로 확인된 방법은 아닙니다.

야간 경련 효과는 미확인

03

풀린 뒤에 알아 둘 것

경련이 풀린 뒤 2~3일은 누르면 아플 수 있습니다. 2주 동안 언제, 얼마나 자주 생기는지 적어 오세요.

2주 일지 → 다시 진료

실천 · 잠결에 넘어지지 않도록 앉은 자세에서 먼저 늘려 주세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

임신·간질환·투석 중이라면

몸 상태에 따라 일반적인 대처와 다른 치료가 필요할 수 있습니다.

간경변

삶의 질을 가장 크게 떨어뜨립니다

간경변이 있다면 진료 때 경련을 먼저 말씀해 주세요. 타우린을 살핀 연구가 있지만 치료는 담당 의사가 정합니다.

혈액투석

투석 처방 조정이 원인에 더 가깝습니다

투석 중이라면 투석 처방부터 확인합니다. 비타민 E와 가바펜틴을 살핀 연구도 있지만 스스로 시작하지 마세요.

임신

중기 이후 흔합니다

임신 중이라면 먼저 종아리 스트레칭처럼 약을 쓰지 않는 방법을 해 보세요. 퀴닌은 쓰지 않습니다.

실천 · 임신·간질환·투석 중이면 먼저 담당 의사와 상의하세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실에서 함께 정할 순서

원인 확인, 스트레칭, 재평가 순서로 함께 결정합니다.

① 구별

실제 근육 경련인가

근육이 단단하게 뭉치고, 늘리면 풀리며, 수 초~수 분 이어졌는지 알려 주세요.

② 위험신호

네 축 훑기

혈관·신경·몸속 수치·복용약을 살피고, 필요한 검사만 고릅니다.

③ 1차 처방

자기 전 스트레칭

자기 전 종아리 스트레칭을 10초씩 3회, 매일 해 보고 6주 뒤 다시 평가합니다.

④ 약물

좁고 신중하게

퀴닌은 사용하지 않습니다. 마그네슘은 부족이 의심될 때만 담당 의사와 상의하세요.

대부분은 여기서 끝납니다

대부분은 원인 설명과 스트레칭으로 관리합니다. 간경변·투석·임신 중이라면 별도로 상의하세요.

실천 · 스트레칭을 해도 반복되면 다시 진료받으세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 같은 자료를 다시 열 수 있습니다.

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

밤에 종아리에 쥐가 나는 분을 위한 설명자료입니다. 약을 시작하거나 바꿀 때는 담당 의사와 상의하세요.

참고한 자료

참고: 야간 경련 지침 · 스트레칭 PMID 22341378 · 마그네슘 32956536, 28241153 · 퀴닌 25842375 · 타우린 30136291, 33381931 · 기타 28192854, 19997012, 19829096, 26586051

SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다